

Incontinência urinária · esforço × urgência

Separe incontinência de esforço (tosse/impacto) da de urgência (bexiga hiperativa). Mista é frequente — trate o componente dominante e invista em terapia comportamental.

Avaliação inicial

Lembre - Avaliação inicial

História, exame, EAS/uropuntura (excluir ITU), diário miccional. Urodinâmica: antes de cirurgia em casos complexos/refratários — não obrigatória em esforço puro típico.

Classificar pelo gatilho muda a 1ª linha: Kegel/sling versus bexiga hiperativa.



Conduta

- Perda de peso, reduzir cafeína, tratar constipação e tosse crônica
- Fisioterapia do assoalho pélvico (Kegel supervisionado)
- Urgência: oxibutinina/outras anticolinérgicas ou mirabegron
- Esforço refratário: sling miduretral (TVT/TOT) em selecionadas

Red flags

Sinal | Pensar em

Hematúria | Tumor / litíase
Neurológico | Bexiga neurogênica
Fístula | Perda contínua pós-cirurgia/parto
Prolapso avançado | Avaliação uroginecológica conjunta

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Não opere esforço sem falha de conservador (salvo exceções). Anticolinérgicos em idosas: delirium e retenção — dose e CI importam.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Incontinência: esforço × urgência × mista; pad test e diário miccional ajudam a objetivar perda.

Três tipos clássicos de incontinência urinária feminina.

Incontinencia - tipos

Esforço / urgência / mista

Esforço

Tosse / riso
sem urgência
hipermobilidade

SUI

Urgência

Urgência sudden
bexiga hiperativa
perda com urge

UII / OAB

Mista

Esforço + urge
tratar dominante
avaliar ambos

MUI

Ideia do pad test (absorvente pesado antes/depois).

Pad test (ideia)

Quantificar perda urinária

peso final - peso inicial = perda (g)

Protocolos 1h ou 24h; >1-2 g em 1h sugere perda significativa

Conduta inicial por tipo

Tipo | 1ª linha | Avançado

Esforço | Piso pélvico, perda de peso | Sling / cirurgia se refratária

Urgência | Treino vesical, anticolinérgico;#2 → Toxina, neuromodulação

Mista | Tratar componente dominante | Combinar medidas

Avaliação básica

Lembre - Avaliação básica

Diário miccional, exame, EAS/cultura se ITU suspeita, resíduo pós-miccional. Pad test objetiva a queixa para prova/clínica.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1